



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

MINISTERIO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Dirección General de Coordinación Hospitalaria, ECNT, VIH/SIDA, TB y otras ETS

Servicio de Coordinación Hospitalaria

Plan de Mejora Urgente de los Hospitales Públicos

**PROPUESTA: MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA PAGO
DE GUARDIAS MÉDICAS EN LOS CENTROS SANITARIOS
PUBLICOS**

Bata, diciembre 2024

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN
2. JUSTIFICACIÓN
3. OBJETIVO
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5. DEFINICION GUARDIA MEDICA
6. ESTRUCTURA JERARGICA DE UNA GUARDIA MEDICA
7. BAREMO DE COSTES DE GUARDIA
 - GUARDIAS FÍSICAS
 - GUARDIAS LOCALIZABLES
8. ¿QUIÉN REALIZA LA GUARDIA?
9. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CUADRANTES DE GUARDIA
10. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE GUARDIAS
11. SUPERVISIÓN Y CONTROL
12. CONSIDERACIONES FINALES

INTRODUCCIÓN

Las guardias médicas representan un componente esencial en la prestación de servicios de salud, asegurando la continuidad de la atención y la respuesta inmediata a las necesidades de los pacientes. Sin embargo, la falta de un marco estandarizado para regular su gestión y pago ha generado inconsistencias en los hospitales públicos. Este protocolo tiene como finalidad establecer lineamientos claros que permitan uniformar los procedimientos relacionados con la planificación, ejecución y remuneración de las guardias médicas, promoviendo la transparencia y la eficiencia en el sistema nacional de salud.

2. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, no existe un protocolo estandarizado tanto en el Ministerio de Sanidad ni en los hospitales, para la gestión y pago de las guardias médicas. Existe una nota circular firmada por el ministro de sanidad, bienestar social e infraestructuras sanitarias con fecha

El presente protocolo viene a reforzar dicha nota circular, proporcionando lineamientos claros y uniformes para su aplicación.

3. OBJETIVO GENERAL

Establecer un procedimiento claro y transparente para el pago de las guardias médicas en hospitales públicos, garantizando la correcta clasificación, validación y tramitación de los pagos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir claramente los conceptos de guardias médicas y su clasificación.
- Establecer los horarios y clasificaciones de turnos de guardia.
- Proporcionar un baremo de costes estandarizado según categoría profesional y tipo de guardia.
- Regular la elaboración y validación de los cuadrantes de guardia, asegurando un proceso organizado y coordinado.
- Detallar el procedimiento para la planificación, validación, y pago de guardias, garantizando transparencia y control.

5. DEFINICIÓN DE GUARDIA MÉDICA

Se entiende por guardia médica el régimen de disponibilidad asistencial en el que el personal sanitario, de manera presencial o localizada, presta atención médica continua fuera del horario ordinario de trabajo, con el propósito de garantizar la cobertura ininterrumpida de urgencias, emergencias y otras necesidades asistenciales.

5.1. Duración de la guardia:

Las guardias tendrán una duración mínima de 12 horas y máxima de 24 horas según los días de jornada y las condiciones de cada hospital.

5.2. Frecuencia:

La frecuencia a realizar guardias hospitalarias será mínima de 4 días (entre 6 a 8 guardias al mes) y máximo de 6 días (4 a 5 guardias al mes). La distribución de las mismas deberá ser equitativa para evitar sobrecarga y fatiga al personal.

5.3. Clasificación de las guardias médicas:

Las guardias médicas se clasifican en:

a. Guardia física:

Modalidad de atención médica en la que el profesional permanece físicamente presente en el centro sanitario fuera de su jornada ordinaria de trabajo, durante un periodo determinado (diurno, nocturno, festivo o de fin de semana), con el fin de garantizar la atención médica continua, inmediata y presencial ante cualquier situación asistencial urgente o emergente.

b. Guardia localizable:

Modalidad de disponibilidad médica en la que el profesional, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, no se encuentra presencialmente en el centro sanitario, pero debe mantenerse accesible por vía telefónica o medio establecido, y en condiciones de acudir al hospital en caso de que se presente una urgencia o necesidad asistencial.

c. Guardia administrativa o de dirección:

Modalidad de guardia asignada al personal de administración o del equipo directivo del centro sanitario, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la toma de decisiones urgentes y la resolución de incidencias administrativas o logísticas fuera del horario ordinario.

Los turnos de guardias médicas se dividirán de acuerdo con el día y horario en el que se realicen, cabe señalar que después de la jornada ordinaria normal, el resto de horas del día son horas extraordinarias, los cuales se cubren realizando la guardia.

Por lo tanto, los turnos de guardia médica se agrupan en tres, y se representan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Turnos de guardia médica

TIPO DE DÍA	DIAS DE LA SEMANA	HORAS
Días ordinarios	Lunes a viernes	16:00 horas a 08:00 horas del día siguiente
Días extraordinarios	Sábados, domingos y festivos	08:00 horas a 08:00 horas del día siguiente

Para el personal de enfermería de las áreas de urgencias y hospitalización, por su carga de trabajo se podrá hacer ajustes internos fraccionando las horas con diferentes equipos de trabajo. (revisar)

Los turnos de fin de semanas (sábado y domingos) y festivos igualmente podrán ser fraccionados y distribuidos por equipos de trabajo.

Se establece como día de descanso, el día que un profesional sale de la guardia (posguardia), debiendo trabajar al día siguiente.

Compensación de las guardias:

Las guardias médicas serán compensadas por remuneración económica conforme a los barremos establecidos por el gobierno. No serán compensados por descansos adicionales.

6. ESTRUCTURA JERARGICA DE LA GUARDIA MEDICA

La guardia médica hospitalaria se organiza en una estructura jerárquica que permite asegurar la atención continua, coordinada y eficaz fuera del horario ordinario. Se organizará con la siguiente estructura:

- a. **Jefe de Guardia Médica:** Responsable de supervisar y coordinar al equipo de guardia, tomar decisiones clínicas de alto nivel y actuar como enlace con la Dirección Médica en caso de emergencias.
- b. **Médicos de guardia:** se encargan de la atención directa a los pacientes, distribuidos por servicios y/o especialidades médicas (urgencias, pediatría, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, etc.).
- c. **Supervisor de turno:** Se encarga de la organización y supervisión de los servicios de enfermería.
- d. **Personal de enfermería:** Se encargan de los cuidados de pacientes durante el turno, trabajarán conjuntamente con los médicos de guardia según distribución de los mismos. Estarán bajo la supervisión y coordinación del supervisor de turno.
- e. **Equipo de apoyo:** La estructura se complementa con (anestesia, laboratorio, radiología, etc.), en modalidad de guardia física o localizable, así como con **personal auxiliar** (camilleros, técnicos, celadores, conductores), que garantizan el soporte operativo.
- f. **Guardia administrativa o de dirección:** Se ocupa de resolver incidencias logísticas, administrativas o de coordinación institucional durante el turno.
- g. **Equipo de control de satisfacción de los servicios asistenciales:**

Esta organización jerárquica permitirá una respuesta rápida, un flujo de trabajo claro y una atención médica segura las 24 horas.

Tabla 2: Estructura jerargica de la guardia medica

ESTRUCTURA / CARGO	FUNCIONES PRINCIPALES
a. Jefe de Guardia Médica	• Supervisar y coordinar la atención médica durante la guardia. • Tomar decisiones clínicas de alto nivel. • Reportar incidencias a la Dirección Médica.
b. Médicos de Guardia por Servicio	• Atender a los pacientes en su área asignada. • Ejecutar diagnósticos, tratamientos e ingresos urgentes. • Coordinarse con el Jefe de Guardia.
c. Supervisor de turno	• Dirigir al personal de enfermería en todos los servicios. • Coordinar con el Jefe de Guardia. • Supervisar la ejecución de cuidados en áreas críticas.
d. Supervisor/a de Turno de Enfermería	• Supervisar el funcionamiento operativo del personal de enfermería en su turno. • Apoyar en la organización del personal en diferentes servicios. • Detectar y reportar incidencias.
e. Enfermeros/as de Guardia	• Ejecutar cuidados directos a los pacientes. • Colaborar con los médicos en procedimientos. • Vigilar y reportar la evolución del paciente.
f. Servicios de Apoyo (localizables o físicos)	• Prestar soporte técnico en su área (Laboratorio, Anestesia, Radiología, etc.). • Acudir en caso de activación. • Emitir informes y resultados.
g. Guardia Administrativa o de Dirección	• Resolver incidencias administrativas o logísticas durante la guardia. • Facilitar recursos y coordinación institucional. • Apoyar al Jefe de Guardia.
h. Oficina del Defensor del Paciente	• Velar por los derechos de los pacientes y familiares durante la guardia. • Atender y canalizar quejas o reclamaciones. • Mediar entre el usuario y el equipo asistencial si fuera necesario.
i. Personal Auxiliar (camilleros, técnicos, etc.)	• Apoyar en el transporte de pacientes, movilización, limpieza de urgencias, etc. • Cumplir tareas operativas según indicaciones del personal clínico.

7. ¿QUIÉN REALIZA LA GUARDIA?

La realización de las guardias médicas es de **carácter obligatorio** para el personal asignado, salvo en las siguientes situaciones específicas:

- **Edad cronológica:** Profesionales mayores de 55 años.
- **Enfermedad limitante:** Justificada mediante certificado médico.
- **Embarazo de riesgo:** Justificado mediante certificado médico.
- **Embarazo:** Profesionales con más de 38 semanas de gestación.

Las guardias físicas las realizara cualquier profesional adscrito en los centros sanitarios públicos, tanto el de perfil sanitario como administrativo.

Un personal sanitario (medico, enfermero/a) adscrito a un centro de salud perteneciente a un determinado distrito sanitario podrá ser programado para realizar guardias médicas físicas en un hospital provincial, distrital o regional del mismo distrito, siempre que se garantice la cobertura mínima en el centro de origen y exista una planificación coordinada con la oficina distrital y la direccion médica del hospital correspondiente.

Las guardias localizables están asignadas solo para personal médico especialista

El personal que no cuente con nombramiento oficial ni contrato en calidad de funcionario público solo podrá participar en la realización de guardias médicas, ya sean físicas o localizables, previa **autorización expresa del Ministerio de Sanidad**, tramitada y validada a través de la **Dirección General de Coordinación Hospitalaria**.

Dicha autorización deberá estar formalizada por escrito, especificando el periodo de validez, el centro de ejecución de las guardias, las condiciones económicas aplicables y los compromisos de responsabilidad del profesional y del centro receptor. Sin esta autorización, no se permitirá la programación ni el reconocimiento administrativo o económico de las guardias realizadas.

4. BARREMO DE RETRIBUCION ECONOMICA DE LAS GUARDIAS MEDICAS

Los barremos para la compensación económica de las guardias médicas se establecen según tipo y categoría profesional, y se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Baremo de retribución de las Guardias físicas

CATEGORIA/CONDICION	COSTE GUARDIA/ORDINARIO	COSTE GUARDIA/SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
MEDICOS ESPECIALISTAS	30.000 XAF	36.000 XAF
MEDICOS GENERALES Y LICENCIADOS	25.000 XAF	30.000 XAF
TECNICOS Y DIPLOMADOS	20.000 XAF	24.000 XAF
AUXILIARES	15.000 XAF	18.000 XAF
SUBALTERNO (Celadores y conductores)	10.000 XAF	12.000 XAF
PERSONAL ODEPAC	10.000 XAF	12.000 XAF
SECRETARIA ASISTENTE PACIENTES	10.000 XAF	12.000 XAF
PERSONAL CAJA	15.000 XAF	18.000 XAF

Como medida de motivación especial, las guardias realizadas en los fines de semana y festivos tendrán un incremento en su baremo según corresponda:

- **Guardias Sábados, Domingos y Festivos:** Incremento del 20% sobre el coste ordinario.

4.2 Guardias localizables

Las guardias localizables se pagarán en función al baremo de retribución de las guardias físicas por categoría profesional, aplicando un 20% de este. Este será distribuido según condición de estar localizable y/o llamada asistida:

- Condición de localizable (mediante cuadrante de guardia localizable): pago del 10 %
- Condición de llamada asistida (Ficha o planilla guardia localizable asistida: 20%

Tabla 3. Baremo de retribución de guardias localizables

CATEGORÍA	BARREMO POR GUARDIA	CONDICION LOCALIZABLE	CONDICION LLAMADA ASISTIDA
MÉDICOS ESPECIALISTAS	30.000 XAF	3.000 XAF	6.000 XAF

- **Nota:** No aplica variación por tipo de jornada (ordinaria, sábados, domingos o festivos).
- **Notificación y validación:** En el caso de las guardias localizables, el profesional deberá ser notificado por el **Jefe de guardia**, quien dará igualmente conformidad de asistencia a la llamada. Dicha asistencia será validada posteriormente por la **guardia de dirección** y agente de la Odepac

4.3. Guardia administrativa o de direccion

La guardia administrativa será pagada conforme al baremo retribución establecido, tendrán un coste de 35.000 por guardia, y aplica a las condiciones de la guardia física.

Tabla 3. Baremo de retribución de guardia administrativa o de direccion

CATEGORIA/CONDICION	COSTE GUARDIA/ORDINARIO	COSTE GUARDIA/SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
GUARDIA DE DIRECCION	35.000 XAF	43.750 XAF

6. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CUADRANTES DE GUARDIA

La elaboración de los cuadrantes de guardia será responsabilidad de los **jefes de servicios y asimilados** y deberá ser validada según corresponda:

- **Dirección Médica:** Validará los cuadrantes correspondientes al personal sanitario.
- **Dirección Administrativa:** Validará los cuadrantes correspondientes al personal administrativo.
- **Dirección de Enfermería:** Los cuadrantes de enfermería deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Enfermería.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE GUARDIAS

1. Planificación y registro

- Los hospitales elaborarán los cuadrantes de guardia, especificando el tipo de guardia, horario, y el personal asignado.
- El borrador del Cuadrante de Guardia del mes siguiente deberá remitirse al departamento de coordinación hospitalaria a más tardar el día 25 de cada mes para conocimiento y constancia.

2. Validación de asistencia

- El registro de asistencia de las guardias médicas deberá ser validado por el jefe de RRHH o asimilado, oficial de la Odepac y los directores de los Hospitales.
- El registro debe diferenciar entre **guardias físicas, localizables y administrativas o de dirección.**
- Rellenar la ficha para las guardias localizable

3. Elaboración de nóminas

- El servicio de Recursos humanos del hospital será el único encargado de elaborar las nóminas de guardias.
- Las nóminas deben contener la siguiente información:
 - Nombre del profesional.
 - Categoría profesional.
 - Número de guardias planificadas.
 - Número de guardias realizadas (clasificadas en ordinarias, extraordinarias, domingos y festivos).
 - En el caso de médicos especialistas, número de guardias localizables
 - Coste de guardia.
- Las nóminas deberán contar con las siguientes firmas:
 - Jefe de RRHH del hospital.
 - Administrador del hospital.
 - Director gerente del hospital.
 - Validación por la dirección general de Coordinación Hospitalaria.

4. Análisis y aprobación

- El equipo técnico de la Coordinación Hospitalaria, en colaboración con el departamento de RRHH, analizará las nóminas presentadas.
- En caso de disconformidad por parte de la Dirección General de Coordinación Hospitalaria, la nómina se devolverá a su procedencia para efectos de modificación.
- Las nóminas aprobadas se remitirán a la de Secretaría de Estado de administración y finanzas (SEAF) mediante un escrito formal expresando su revisión y conformidad para su tramitación.

5. Tramitación del pago

- La SEAF mediante la sección correspondiente validará el expediente y lo elevará al Sr. ministro para su consideración y firma
- La sección económica del Ministerio de Sanidad solo se limitará a la tramitación del pago, en ningún momento deberá elaborar otra nómina.

- El expediente aprobado, validado por SEAF y firmado por el ministro de sanidad, será remitido por los canales habituales a la Tesorería General de Estado para su pago.

6. Formas de pago

- **Transferencia bancaria desde la cuenta del Ministerio para tal efecto a la cuenta del trabajador:** Esta es la forma de pago actual y principal.
- **Transferencia a la cuenta bancaria del hospital:** Se realizará una transferencia desde la cuenta bancaria del ministerio (para tal efecto) a la de cada hospital. El hospital preparará el cheque correspondiente al importe de la nómina y procederá al pago en caja al trabajador. **Esta modalidad garantiza la aplicación de sanciones por ausencia u otras faltas, reteniendo el incentivo de guardia cuando corresponda.**

7. Plazos de entrega

- Los cuadrantes de guardia y sus nóminas deberán remitirse a la Coordinación Regional y/o Dirección General antes del día 20 al día 25 de cada mes.
-

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL

- La Coordinación Hospitalaria, Dirección general de RRHH e IGSN serán responsable de supervisar el cumplimiento de este protocolo.
- No se realizarán pagos por guardias que no estén debidamente registradas, validadas y firmadas.

9. CONSIDERACIONES FINALES

- **Transparencia:** Todos los procesos relacionados con el pago de guardias serán auditables en base al presente manual.
- **Revisión del protocolo:** El presente protocolo será revisado periódicamente para adaptarse a las necesidades de los hospitales públicos.
- **Cumplimiento obligatorio:** Este manual tiene un carácter de obligado cumplimiento por todos los servicios intervinientes por cada estructura identificado.

EQUIPO TECNICO DE ELABORACION:

Dr. Crisologo Mba Azeme Andeme

Dr. Candido Ondo

Asistente Técnico Servicio de Coordinación Hospitalaria

Dra. Agustina Modesta Nnnom Nse

Asistente Técnico Servicio de Coordinación Hospitalaria

APROBADO POR:

Ilma Sra. Leticia Nseng Ondo Ayecaba.

Directora General de Coordinación Hospitalaria, ECNT,
VIH/SIDA, TB y Otras ETS

VALIDADO POR:

Excmo. Sr. Mitoha Ondo Ayecaba

Ministro de Sanidad, Bienestar Social e Infraestructuras Sanitarias